TÓM TẮT LÝ THUYẾT · TAI - MŨI - HỌNG

BÀI 1 Liên quan giữa Tai Mũi Họng và các chuyên khoa

Tóm tắt từ bài giảng 1. LIEN QUAN TMH update 2.pdf (55 trang) · Giữ ý chính và số liệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐẠI CƯƠNG
2. LIÊN QUAN VỚI NỘI KHOA
3. NGOẠI KHOA – NHI KHOA – SẢN KHOA
4. RĂNG HÀM MẶT VÀ MẮT
5. KHOA NHIỄM
6. THẦN KINH VÀ TÂM THẦN
7. DA LIỄU
8. LAO – BỆNH PHỔI
9. VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

1. ĐẠI CƯƠNG

- **Cơ thể là một khối thống nhất**, nên bệnh Tai Mũi Họng (TMH) liên quan chặt chẽ với **Nội, Ngoại, Sản, Nhi** và nhiều chuyên khoa khác.
- **Tai** là cửa ngõ của hệ thống **nghe và thăng bằng**; **mũi** là cơ quan **đầu tiên của hệ hô hấp**; **họng** là **cửa ngõ của đường ăn**.
- Có khi tổn thương **không ở TMH nhưng triệu chứng lại xuất hiện ở tai, mũi, họng**, và ngược lại bệnh TMH có thể biểu hiện ở cơ quan khác → bác sĩ mọi chuyên khoa cần biết để **tránh bệnh nhân đi từ khoa này sang khoa khác**, điều trị tận gốc, nhanh và ít tốn kém.

2. LIÊN QUAN VỚI NỘI KHOA

Mỗi triệu chứng cần phân biệt **bệnh TMH** với **bệnh không thuộc TMH**:

Triệu chứng	Bệnh TMH	Không phải bệnh TMH
Chảy máu mũi	U máu ở mũi, viêm mũi, viêm xoang, **ung thư vòm**, **u xơ vòm mũi họng**	**Tăng huyết áp**, sốt rét, sốt xuất huyết, **bệnh gan**, xuất huyết giảm tiểu cầu
Khạc ra máu	**Chảy máu mũi sau**, dãn TM đáy lưỡi, viêm xoang, chấn thương xoang, ung thư vòm mũi họng	**Lao phổi**, **dãn phế quản**, **K phổi**
Đau họng	Viêm họng, viêm amidan	**Dài mỏm trâm**, **GERD**
Nhức đầu	**Viêm xoang**, **điểm tiếp xúc**, **gai vách ngăn**, dị vật đường ăn	Viêm màng não, viêm não, nhức đầu vận mạch, **đau dây V**, khối choán chỗ (u, tụ máu)

- **Nôn ra máu:** biểu hiện ở họng nhưng có thể là bệnh **xơ gan (vỡ dãn tĩnh mạch thực quản)**.
- **Khạc ra mủ:** viêm phế quản mạn, **dị vật đường thở**, áp xe phổi.
- **Dị ứng:** hen phế quản, mày đay, chàm, **phù Quincke**.
- **Nhiễm HIV: nấm vùng TMH** (nấm họng, thực quản), **Sarcome Kaposi**.

3. NGOẠI KHOA – NHI KHOA – SẢN KHOA

- **Ngoại khoa:** TMH phẫu thuật **khối u vùng đầu mặt cổ**; phối hợp với **ngoại thần kinh, ngoại lồng ngực, mắt**.
- **Nhi khoa:** viêm amidan và VA, **khó thở thanh quản**, **dị vật thanh khí phế quản**, viêm tai giữa cấp ở hài nhi, **điếc câm**.
  - **HC Kuhn:** viêm xoang polyp + **dãn phế quản**.

- **HC Kartagener:** viêm xoang polyp + dãn phế quản + **đảo phủ tạng**.
- **Sản khoa (dị dạng bẩm sinh):**
  - Không nguy hiểm tính mạng: **tắc cửa mũi**, **tật sứt môi**, **HC Franchesti** (dị dạng tai ngoài, mắt xếch, lưỡi to, răng lộn xộn).
  - **Nguy hiểm tính mạng: rò khí – thực quản**.

4. RĂNG HÀM MẶT VÀ MẮT

- **Răng hàm mặt: sâu răng, u nang răng → viêm xoang**; đau dây V; **HC Costen** (đau **khớp thái dương hàm**); **lệch khớp cắn → nhức đầu, ù tai**.
- **Mắt:** viêm xoang có thể gây **mờ mắt**, **áp xe quanh ổ mắt**, **viêm tắc xoang tĩnh mạch hang**.

5. KHOA NHIỄM

- **Viêm xoang cấp** và **viêm tai xương chũm hồi viêm** đều có thể gây **viêm màng não** nặng → TMH phối hợp khoa Nhiễm để cứu sống bệnh nhân.
- **Uốn ván, viêm não, liệt hô hấp** gây khó thở nặng → BS TMH **mở khí quản**.
- Trẻ em bị **sởi, cúm, bạch hầu, tinh hồng nhiệt** có thể khó thở nặng (mở khí quản) và **viêm tai giữa**.

6. THẦN KINH VÀ TÂM THẦN

- **Chóng mặt:** gặp trong **u dây VIII**, **xơ cứng rải rác**, **suy động mạch đốt sống**, rỗng thành não.
- **Suy nhược thần kinh** (nhức đầu, mất ngủ, kém ăn, giảm trí nhớ, không tập trung) thường do **viêm nhóm xoang sau** → điều trị xoang ổn thì triệu chứng hết.
- **Áp xe não do tai, do xoang:** BS TMH chẩn đoán và mổ; có bệnh thần kinh trung ương kèm theo thì nhờ **ngoại thần kinh**.
- **Bệnh Horton (viêm ĐM thái dương nông):** đau vùng thái dương, da đỏ, bóng, nóng; **đè ĐM thái dương nông thì đau**; diễn tiến từng đợt, nặng có thể **mù mắt**.
- **Đau dây V:** đau từng cơn rất ngắn **như điện giật** (trán, thái dương, má, lưỡi), nhất là khi nói, ăn. **Nguyên phát → BS thần kinh**; **thứ phát do xoang → BS TMH**.
- **Tai biến mạch máu não:** liệt dây **IX, X, XI**, có khi cả **XII** → khó nuốt, nuốt sặc, chảy nước bọt, khó nói; mất ngôn ngữ.
- **Liệt hành não thật hoặc giả:** khó nuốt, nuốt sặc, **liệt màn hầu, liệt thanh quản** – bệnh nhân tự đi khám TMH nhưng thực sự là **bệnh thần kinh**.
- **Tâm thần:** hoang tưởng **bị ung thư họng**; tăng trương lực cơ, trầm cảm → đau đầu giống viêm xoang; **xúc động mạnh đột ngột → mất tiếng, câm**.

7. DA LIỄU

- **Bệnh phong: vành tai và tháp mũi** bị **VK Hansen** tấn công; chẩn đoán bằng **lấy chất nhầy mũi, nhuộm, soi kính hiển vi**.
- **Giang mai:** tấn công **tai trong** → viêm thần kinh mê nhĩ → **điếc tai trong**; **giang mai bẩm sinh** là nguyên nhân thường gặp của **điếc trẻ em**.
- **Viêm mũi lậu:** thường **đi đôi với viêm mắt lậu**, do vi trùng **ở âm đạo mẹ** xâm nhập lúc sinh.
- **Chàm:** trẻ nhỏ **viêm tai giữa chảy mủ → chàm ở mặt**, khỏi khi hết mủ tai.
- **Duhring – Brocq** (giống Herpes) gây đau, loét họng miệng; **Pemphigus** nổi bóng nước ở da, niêm mạc mắt, miệng, họng, thực quản.

8. LAO – BỆNH PHỔI

- TMH là cộng tác viên của chuyên khoa lao trong **nội soi khí phế quản**.
- **Lao thanh quản:** phản ánh khá trung thực diễn biến lao phổi – bệnh nhân lao phổi đến khám vì **khàn tiếng**, soi thấy **loét lao ở dây thanh**.
- **Dãn phế quản thể khô: khạc ra máu**, chẩn đoán khó → **soi phế quản, chụp phế quản có cản quang**.
- **Lao phổi giả: viêm xoang mạn** cho triệu chứng giống lao, nhưng **BK đàm âm, IDR âm, máu lắng và phim phổi bình thường**; **phim Blondeau, Hirtz** thấy xoang mờ, **thường là xoang sàng**.
- **Lao phế quản:** ho, khạc ra vi trùng nhưng **nhu mô phổi trên phim bình thường**; soi phế quản thấy **loét đặc hiệu**, sinh thiết xác định lao.

9. VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

- **Tiếng ồn > 100 dB** (máy nổ, máy dệt, máy nghiền đá) → **điếc nghề nghiệp**; rung động máy cũng hại tai.
- **Bụi** (xi măng, lò vôi, mỏ than, lông vũ) chứa hóa chất độc, vi khuẩn hại mũi, họng, phổi.
- **Chất thải công nghiệp** ảnh hưởng môi trường → khu công nghiệp phải có bộ phận xử lý.
- **Thay đổi áp lực lớn, đột ngột** (**thợ lặn, phi công**) hại tai, có thể nguy hiểm tính mạng.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế bài giảng gốc. Đối chiếu 1. LIEN QUAN TMH update 2.pdf khi cần chi tiết.